

Ley 19.628 y Ley 21.719

Chile cuenta con dos marcos legales que regulan el tratamiento de datos personales y, especialmente, **datos sensibles de salud**, que son los que utiliza MediTriage. Estas leyes establecen cómo deben recolectarse, almacenarse, procesarse y protegerse los datos de los pacientes, y qué derechos tienen las personas sobre su información.

Ley 19.628 — Sobre Protección de la Vida Privada (1999)

Es la ley histórica que reguló por primera vez el tratamiento de datos personales en Chile. Aunque hoy está siendo reemplazada, sigue siendo la base conceptual.

¿Qué define esta ley?

- **Dato personal:** cualquier información que identifica a una persona (nombre, RUT, correo, dirección).
- **Dato sensible:** información que afecta la esfera íntima, como **datos de salud**, orientación sexual, religión, etc.
- **Consentimiento:** para tratar datos sensibles se requiere autorización explícita del titular.
- **Finalidad:** los datos solo pueden usarse para el propósito declarado.
- **Seguridad:** el responsable debe proteger los datos contra accesos no autorizados.

Ley 21.719 — Nueva Ley de Protección de Datos Personales (2024–2026)

Esta ley moderniza completamente la 19.628 y establece un marco similar al **GDPR europeo**. Es mucho más estricta y exigente, y entrará en plena vigencia el 1 de diciembre de 2026.

Cambios importantes introducidos por esta ley

- **Crea la Agencia de Protección de Datos Personales**, que fiscaliza y sanciona.
- **Multas severas:** hasta 20.000 UTM por incumplimiento.
- **Principios obligatorios:** licitud, finalidad, proporcionalidad, calidad, seguridad, transparencia, confidencialidad y responsabilidad.
- **Derechos ARSOP:** acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y revisión de decisiones automatizadas.
- **Brechas de seguridad:** deben notificarse a la Agencia y a los afectados.

- **Tratamiento de menores:** requiere consentimiento del representante legal.
- **Transferencias internacionales:** solo a países con protección equivalente.

¿Qué exige la ley para un sistema como MediTriage?

Consentimiento informado: El paciente debe aceptar explícitamente el tratamiento de sus datos sensibles.

Minimización de datos: Recolectar solo lo necesario para el triage.

Anonimización: PII (nombre, RUT, correo) no debe llegar al motor IA ni aparecer en logs.

Cifrado en tránsito y reposo: HTTPS/WSS + pgcrypto en PostgreSQL.

Auditoría y trazabilidad: Cada recomendación IA debe quedar registrada con:

- versión del modelo
- datos clínicos usados (sin PII)
- explicación generada
- timestamp
- usuario que ejecutó la acción

Explicabilidad y revisión humana: El paciente tiene derecho a entender y cuestionar decisiones automatizadas.

Por eso MediTriage debe:

- explicar por qué asignó ESI 1–5
- permitir revisión por personal médico

Notificación de brechas: Si ocurre una filtración, debe notificarse a la Agencia y a los afectados.

Protección de menores: Si el sistema atiende pediatría, se requiere consentimiento del apoderado.

Qué es el GDPR (General Data Protection Regulation)

El **GDPR** es la ley de protección de datos de la Unión Europea, vigente desde 2018.

Es considerada **la normativa más estricta del mundo** en privacidad y tratamiento de datos personales.

Chile, con la **Ley 21.719**, está adoptando un modelo **muy similar** al GDPR.

ESI — Emergency Severity Index

Sistema internacional de clasificación de urgencias (niveles 1 a 5)

El ESI (Emergency Severity Index) es un sistema utilizado en servicios de urgencias para clasificar a los pacientes según la gravedad de su condición y la cantidad de recursos clínicos que necesitarán.

Su objetivo es priorizar la atención de manera rápida, segura y estandarizada.

¿Qué evalúa el ESI?

El ESI clasifica a los pacientes considerando dos factores:

A) Gravedad inmediata (riesgo vital)

¿El paciente está en peligro de muerte o deterioro inmediato?

B) Cantidad de recursos clínicos necesarios

¿Requerirá múltiples exámenes, imágenes, procedimientos o solo uno? ¿O no necesitará ninguno?

Los 5 niveles del ESI

ESI 1 — Atención inmediata (riesgo vital)

El paciente está **crítico** y necesita intervención **en segundos**.

Ejemplos:

- Paro cardiorrespiratorio
- Shock
- Vía aérea comprometida
- Saturación extremadamente baja
- Inconsciencia profunda

Prioridad: máxima.

Acción: atención inmediata sin esperar recursos.

ESI 2 — Muy urgente (alto riesgo)

El paciente no está en paro, pero presenta **alto riesgo de deterioro**.

Ejemplos:

- Dolor torácico fuerte (posible infarto)
- Signos de sepsis (fiebre alta + taquicardia + hipotensión)
- Alteración del estado mental
- Trauma severo
- Sospecha de ACV

Prioridad: casi inmediata.

Acción: evaluación rápida y acceso prioritario a recursos.

ESI 3 — Urgente (requiere varios recursos)

El paciente está estable, pero necesita **múltiples recursos diagnósticos**.

Ejemplos:

- Fiebre alta con síntomas respiratorios
- Dolor abdominal moderado
- Deshidratación
- Fracturas estables
- Crisis asmática leve a moderada

Prioridad: alta, pero puede esperar un poco.

Acción: exámenes, imágenes, laboratorio, etc.

ESI 4 — Menos urgente (requiere 1 recurso)

El paciente está estable y solo necesita **un recurso clínico**.

Ejemplos:

- Heridas menores
- Dolor leve
- Infecciones simples
- Sospecha de fractura leve (solo radiografía)

Prioridad: media.

Acción: un examen o procedimiento.

ESI 5 — No urgente (no requiere recursos)

El paciente está estable y **no necesita exámenes ni procedimientos**.

Ejemplos:

- Resfrío común
- Dolor leve sin signos de alarma
- Motivos administrativos
- Consulta de control sin síntomas

Prioridad: baja.

Acción: atención ambulatoria o derivación.